ZGŁOSZENIE SZKODY Z OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC ORAZ WEZWANIE DO ZAPŁATY ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA

....., dnia ..... r.
(miejscowość, data)

Poszkodowany / Poszkodowana:

Imię i nazwisko: .....
Adres zamieszkania: .....
PESEL (lub seria i nr paszportu w przypadku braku PESEL): .....
Nr telefonu: .....
Adres e-mail: .....
Numer rachunku bankowego do wypłaty świadczeń: .....

Adresat (proszę wybrać jeden wariant i drugi skreślić):

Wariant A (zalecany) — Zakład Ubezpieczeń / Towarzystwo Ubezpieczeń (Departament Likwidacji Szkód), w którym sprawca posiadał polisę OC — podstawa: art. 822 § 4 KC (*actio directa*).
Wariant B — Podmiot leczniczy / lekarz dentysta (sprawca szkody) — gdy dane ubezpieczyciela nie są jeszcze znane albo roszczenie kierowane jest równolegle do sprawcy. .....
(Nazwa Zakładu Ubezpieczeń S.A. / Towarzystwa Ubezpieczeń lub Podmiotu Leczniczego)
.....
(Adres centrali / Departamentu Likwidacji Szkód lub adres podmiotu leczniczego)

Dotyczy: Zgłoszenia szkody z obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą / lekarza dentysty.

Sprawca szkody (Ubezpieczony):
Nazwa podmiotu leczniczego / Lekarz: .....
Adres placówki: .....
Seria i numer polisy OC: .....
Numer szkody (jeśli został już nadany): .....

ZGŁOSZENIE SZKODY I WEZWANIE DO ZAPŁATY

Działając we własnym imieniu, na podstawie art. 822 § 4 Kodeksu cywilnego (*actio directa* — bezpośrednie roszczenie przeciwko ubezpieczycielowi sprawcy) oraz przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

1. **ZGŁASZAM SZKODĘ NA OSOBIE ORAZ SZKODĘ MAJĄTKOWĄ** doznaną w wyniku błędu diagnostyczno-terapeutycznego (zaniechania prawidłowej diagnozy i leczenia na podstawie badania obrazowego — tomografii stożkowej CBCT *(Cone Beam Computed Tomography, trójwymiarowe badanie 3D)*), popełnionego w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego;
2. **WZYWAM DO ZAPŁATY** w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego zgłoszenia (art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych) następujących kwot na wyżej wskazany rachunek bankowy: - **a) kwoty ..... zł** *(słownie: .....)* tytułem **odszkodowania — wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia naprawczego** (art. 444 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego) zgodnie z załączonym planem leczenia i kosztorysem z dnia ..... r., z jednoczesnym zastrzeżeniem prawa do żądania zwrotu dalszych kosztów leczenia powikłań; - **b) kwoty ..... zł** *(słownie: .....)* tytułem **zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, ból i cierpienie fizyczne oraz psychiczne** (art. 445 § 1 w zw. z art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego); - **c) kwoty ..... zł** *(słownie: .....)* tytułem **odszkodowania za poniesione dotychczas koszty leczenia, badań diagnostycznych, leków i dojazdów** (art. 444 § 1 zd. 1 Kodeksu cywilnego) — zgodnie z załączonymi rachunkami i fakturami.

Niniejsze zgłoszenie roszczenia (zdarzenia) przerywa bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela (art. 819 § 4 KC). Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym otrzymam pisemne oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

I. STAN FAKTYCZNY I CHRONOLOGIA ZDARZEŃ

0. **Historia wcześniejszego leczenia (wypełnić w wariancie nawrotu / kontroli po zabiegu; w wariancie pierwotnego przeoczenia pominąć):** Wcześniej w placówce ubezpieczonego wykonano: ..... *(np. resekcja wierzchołków korzeni zębów nr ..... + wyłuszczenie torbieli w dniu ..... r.)*. Kontrole po zabiegu (m.in. CBCT z dnia ..... r.) wykazywały obraz prawidłowy / prawidłowe gojenie, bez wskazań do leczenia.

1. **Wizyta sporna — data zarzutu (dzień ..... r.):** Poszkodowany/a odbył/a wizytę stomatologiczną w placówce ubezpieczonego. W trakcie wizyty wykonano badanie obrazowe — tomografię stożkową CBCT: ..... *(obszar ..... / ząb nr .....)*. Lekarz badający oświadczył, że badanie nie wykazuje zmian chorobowych i brak jest wskazań do podjęcia leczenia stomatologicznego. Nie wdrożono leczenia ani dalszej diagnostyki. Zalecenie: kontrola za ..... . *W wariancie nawrotu jest to kontrola po wcześniejszym*

skutecznym leczeniu (pkt 0), a zarzut dotyczy przeoczenia nawrotu, nie pierwotnego rozpoznania.

2. **Wystąpienie powikłań (okres ..... r.):** W kolejnych tygodniach nastąpił dynamiczny rozwój nierozpoznanego stanu zapalnego. U Poszkodowanego/ej wystąpiły ostre objawy chorobowe: narastający ból o dużym natężeniu, rozległy obrzęk tkanek miękkich twarzy po stronie ....., zaburzenia snu, trudności w przyjmowaniu pokarmów oraz ogólne rozbicie. Objawy te udokumentowano fotograficznie oraz potwierdzono w wywiadzie lekarskim. *Jeżeli między sporną kontrolą a weryfikacją wystąpiła przerwa w zgłaszaniu się na kontrole (np. objawy w miesiącu ....., brak wizyty), opisać ją zgodnie z prawdą w jednym zdaniu — ubezpieczyciel bada przyczynienie (art. 362 KC). Nie pomijać tego faktu; osią roszczenia pozostaje sporna kontrola z pkt 1.*

3. **Wizyta weryfikacyjna i ujawnienie błędu (dzień ..... r.):** Z uwagi na ostry stan zapalny Poszkodowany/a zgłosił/a się na pilną konsultację stomatologiczną do innego lekarza dentysty: ..... Lekarz ten, po badaniu fizykalnym (naocznym zbadaniu stanu klinicznego), wykonaniu własnej tomografii CBCT oraz wnikliwej analizie spornego badania CBCT z dnia ..... r., jednoznacznie stwierdził, że:

    - Zmiany chorobowe w postaci: ..... były **wyraźnie widoczne już w spornym badaniu CBCT**;
    - Prawidłowa ocena radiologiczna nakazywała natychmiastowe wdrożenie leczenia już w dacie spornego badania;
    - Zaniechanie leczenia doprowadziło bezpośrednio do rozwoju ostrego stanu zapalnego, obrzęku / ropnia i konieczności wdrożenia skomplikowanego, inwazyjnego leczenia naprawczego: .....;
    - Koszt niezbędnego leczenia naprawczego został oszacowany w załączonym planie leczenia na kwotę: ..... zł. *Dowód kluczowy w wariancie nawrotu: pisemna opinia lekarza weryfikującego porównująca DICOM CBCT ze spornej kontroli z własnym CBCT (dwa badania, daty, opis różnic).*

II. PODSTAWA PRAWNA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. **Art. 415 Kodeksu cywilnego (wina sprawcy):** Zaniechanie właściwej analizy badania CBCT i przeoczenie widocznych zmian chorobowych stanowi naruszenie zasad aktualnej wiedzy medycznej oraz niedochowanie należytej staranności zawodowej wymaganej od lekarza dentysty (art. 355 § 2 KC w zw. z art. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
2. **Art. 430 Kodeksu cywilnego (odpowiedzialność zwierzchnika):** W przypadku podmiotu leczniczego placówka odpowiada za szkodę wyrządzoną z winy personelu medycznego wykonującego czynności powierzone w ramach jej działalności.

3. **Art. 444 § 1 i art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego:** Naprawienie szkody na osobie obejmuje wszelkie wynikłe z tego koszty. Na żądanie poszkodowanego podmiot zobowiązany jest wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. Nadto poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę niemajątkową (ból, zniekształcenie twarzy, cierpienie, stres, utrudnienia w życiu codziennym).
4. **Art. 822 § 1 i § 4 Kodeksu cywilnego:** Ubezpieczyciel przez umowę ubezpieczenia OC przejmuje odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone osobom trzecim, a poszkodowany uprawniony jest do dochodzenia roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.
5. **Art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:** Termin na likwidację szkody i wypłatę należnych świadczeń wynosi 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

III. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Kopia dokumentacji medycznej z placówki ubezpieczonego (karty wizyt, historia leczenia);
2. Płyta CD / pendrive / nośnik z cyfrowym zapisem badania CBCT z dnia ..... r. (format DICOM) wraz z opisem radiologicznym;
3. Zaświadczenie lekarskie / pisemna opinia lekarza weryfikującego błąd z dnia ..... r.;
4. Plan leczenia naprawczego wraz ze szczegółowym kosztorysem procedur z dnia ..... r.;
5. Dokumentacja fotograficzna obrzęku twarzy i widocznych powikłań (z oznaczeniem dat);
6. Kopie imiennych faktur i rachunków potwierdzających dotychczas poniesione koszty leczenia, badań, leków i dojazdów;
7. Dziennik dolegliwości bólowych, gorączki, bezsenności i wykaz przyjmowanych leków;
8. Zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy (zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, tzw. L4) wynikające z powikłań (opcjonalnie);
9. Kopia uprzednio złożonego wniosku o udostępnienie dokumentacji i wskazanie polisy OC wraz z potwierdzeniem odbioru.

Uwaga: W przypadku trudności z samodzielnym oszacowaniem roszczeń lub w razie sporu co do winy ubezpieczonego, poszkodowany może skorzystać z bezpłatnej pomocy Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Rzecznika Praw Pacjenta lub profesjonalnego pełnomocnika (adwokata / radcy prawnego).

IV. POUCZENIE I DALSZE KROKI

W przypadku bezczynności, odmowy wypłaty odszkodowania lub zaniżenia kwoty świadczeń, zastrzegam sobie prawo do: 1. Skierowania wniosku o postępowanie interwencyjne do Rzecznika Finansowego; 2.

Złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy właściwej Okręgowej Izbie Lekarskiej; 3. Wytoczenia powództwa cywilnego przed sąd powszechny wraz z żądaniem ustawowych odsetek za opóźnienie od dnia wymagalności roszczenia.

Z poważaniem,

.....

(własnoręczny podpis Poszkodowanego / Poszkodowanej)